2.1.5.2. 회송(전원)

제 정 일	2002.02.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	진료협력센터				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 2.1.5 퇴원 및 전원 절차 JCI Standard 7th Edition: ACC.1, 4, 5, 5.1, 6

제1조 (목적)

1. 진료의 연속성을 유지하기 위해 회송(전원) 및 의뢰 결정과정에 환자가 참여하며 적절한 절차를 제공하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 회송(전원, Inter Hospital Transfer): 외래 및 입원환자 중 연속적, 후속적인 진료가 요구되어 타 병원으로 회송(전원)의뢰 및 이송되는 일련의 과정

제3조 (절차)

1. 환자 참여: 환자 및 보호자가 회송(전원)과 회송(전원)과정에서의 정보제공에 동의하면 회송(전원)병원 선정 및 회송(전원)병원 승인을 위한 진료정보 제공 절차를 진행하며, 이 과정에서 환자 및 보호자를 참여시킨다.

2. 회송(전원) 하는 경우
   1) 병동/중환자실/응급진료센터 등 병상이 부족한 경우
   2) 병원에서 제공하지 못하는 특별한 서비스가 요구되는 경우(격리실, 중환자실, 분만실 외)
   3) 완화의료서비스가 요구되는 경우
   4) 급성기 진료가 종료되고, 연속적인 치료가 요구되어 장기 요양이 필요한 경우
   5) 급성기 진료가 종료되고, 후속적인 관리를 위해 병·의원으로 의뢰하는 경우
   6) 환자 또는 대리인이 요청한 경우
   7) 기타 회송(전원)이 요구되는 경우 등

3. 회송(전원) 전 의료기관 선정 및 준비
   1) 의사는 환자 회송(전원)을 결정하고 환자 및 보호자에게 회송(전원)에 대해 설명하고 동의를 구한다.
   2) 환자의 진료 연속성 요구와 일치하는 회송(전원)기관(완화의료전문기관 포함)을 선정한다.
   3) 회송(전원)기관의 수용능력을 확인한다.
   4) 이송수단
      (1) 입원 환자의 회송(전원) 시 적합한 이송수단을 확인하고 이송에 필요한 교통수단(구급차, 항공 등)에 관한 정보를 제공한다.

(2) 비행기 이송이 필요한 경우, 가능한 항공사 담당부서와 병약승객항공운송에 관한 절차를 연계한다.

(3) 의사 또는 응급구조사 동승이 필요한 이송의 경우, 본원 구급차 또는 위탁업체 구급차를 사용한다.

5) 의료진 동반의 필요성

(1) 의료진 동반 필요성을 확인하기 위한 회송(전원)환자 분류는 [부록1. 세브란스병원 중환자 이송체계(STARS)]에 따른다.

① Class I: 현재 환자의 상태가 불안정하며 이송 중 악화가능성이 높은 환자

② Class II: 이송 중 악화가능성이 있고 지속적 약물 투입 또는 환자감시가 필요한 환자

③ Class III: 이송 중 악화가능성이 낮은 환자

(2) Class I, II에 해당하는 경우 의사 또는 응급구조사가 동행한다. ClassIII에 해당하는 환자는 필요 시 응급구조사가 동행한다.

(3) 동행 시 회송(전원) 중 환자의 상태를 점검하며 필요 시 적절한 조치를 취하고 기록한다.

4. 회송(전원) 시 정보제공

1) 해당 회송(전원)기관에서 환자 회송(전원)을 승인하면 회송(전원) 시 상태와 치료에 대한 정보, 회송(전원) 사유 등이 기재된 자료(의뢰서 또는 회송서, 환자용 퇴원요약, 의무기록, 영상복사 등)를 첨부하여 회송(전원)기관에 제공한다.

5. 회송(전원) 사유, 회송(전원)기관 정보, 이송방법 등을 해당 환자 의무기록에 기록한다.

6. 의사는 입원환자의 회송(전원) 및 이송과정에 책임이 있으며, 회송(전원) 후에는 회송(전원)기관과 의료진에게 책임이 이관된다. 회송(전원)받는 병원 소속 의료진이 본원에 와서 환자를 인계받는 경우, 인계 이후 환자 관리 책임은 해당 타 병원으로 이관된다.

7. 타 병원으로 회송(전원)이 불가능한 경우에는 가정전문간호사실 협의진료 의뢰를 고려한다.

8. 환자가 타 병원에서 본원으로 의뢰되는 경우 진료정보회신 동의서를 작성한 환자에 한하여 해당 병원으로 진료결과를 회신한다.

9. 환자 진료의 연속성을 유지하기 위해 회송(전원)기관과 지속적인 협력 관계를 유지한다.

10. 협력병원(기관) 운영

1) 협력병원(기관)은 특별한 이해관계 없이 진료협력 협약을 체결한 후 진료의뢰, 회송(전원) 및 행정 협력을 위한 진료협력 네트워크를 의미한다.

2) 협력병원(기관) 관련 업무는 진료협력센터(SHRC, Severance Hospital Referral Center)에서 주관한다.

3) 협력병원(기관) 선정 시 병상수, 진료과목, 전문서비스 및 시설 등을 고려하여 진료협력위원회에서 검토 후 병원장이 결정한다.

4) 진료협력 협약 체결 요청 시 '세브란스병원 협력병원(기관) 체결 심의 자료 조사표'를 작성하고 필요한 서류를 구비하여 제출한다.
5) 협약기간은 협약을 체결한 날로부터 2년이며 재협약을 체결할 수 있다.
6) 재협약 체결 시 진료협력 실적에 대한 해당 병원의 의견 및 재협약 체결 신청서 등을 제출한다.
7) 재협약 기간 동안 진료협력 실적 등을 검토하여 진료협력위원회의 심의를 거쳐 협약을 종결할 수 있다.
8) 협약서의 내용은 진료협력위원회의 심의를 거쳐 병원장이 최종 결정한다.
9) 협력병원(기관) 협약서에 상호 대표자가 날인함으로써 협약을 체결한다.
10) 체결 후, 협력병원(기관)에 대한 진료의뢰, 회송(전원), 행정협력에 대한 평가 등을 실시한다.
11) 상호간의 진료활동 교류, 정보 교류, 업무상의 협력, 협력병원의 지정표시 등에 관하여 협력한다.

제4조 (부록)
1. 세브란스병원 중환자 이송체계(STARS)

제5조 (참고)

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)
1. 이 내규는 2002년 2월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)
1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)